oct 17, 2026

Reunión del 17 oct 2026 a las 09:03 GMT-03:00

Registros de la reunión Transcripción

Resumen

Revisión de proyectos con ajustes de fichas y cobros.

Ajustes de fichas médicas
Se eliminaron historias de usuario y se ajustaron permisos de visualización.

Gestión de cobros
Se determinó generar comprobantes automáticos de pago tras la asistencia.

Decisiones

Acordada

- **Restricción de edición de fichas médicas** Se estableció que las fichas médicas solo pueden ser editadas el mismo día de la consulta y cualquier modificación posterior requiere una nueva consulta médica.
- **Eliminación de historia de usuario de cobertura** Se acordó eliminar del proyecto la historia de usuario relacionada con la gestión y corrección de cobertura de pacientes por parte del administrativo.
- **Separación del marcado de asistencia y pagos** Se determinó que el estado de completado por parte del médico solo habilitará la carga de la ficha médica, manejando los pagos por separado en administración.
- **Estructura de fichas médicas separadas** Se acordó modelar las fichas médicas como registros separados por consulta en lugar de un documento acumulativo único.

- **Visualización condicional de pantallas por rol** Se estableció que los usuarios y administradores compartirán la misma interfaz de pantalla, condicionando la visualización de los botones de acción según el rol del usuario.
- **Configuración de turnos de vacunación** Se configuró la historia de usuario 28 como turno de vacunación para usuarios, asignándola también para el uso del rol de enfermera.
- **Mantenimiento de la configuración de pantallas** Se acordó mantener sin modificaciones la configuración actual de las pantallas asignadas a la enfermera y al personal administrativo.

Próximos pasos

[Agustín Echavarria] Actualizar plan demo: Modificar el plan de demostración y las diapositivas para alinearlos con las entregas del proyecto.

[Agustín Echavarria] Ajustar cronograma proyecto: Sincronizar el cronograma del proyecto para asegurar que las tareas encajen con los días de entrega establecidos.

[Luca Fueyo] Actualizar historias usuario: Modificar las historias de usuario 32, 33 y las relacionadas con la gestión de coberturas médicas según lo discutido.

[Luca Fueyo] Subir cambios repositorio: Cargar todas las modificaciones y correcciones realizadas en el código al repositorio de Git.

[El grupo] Modificar wireframes: Ajustar los wireframes para incluir el flujo de pagos, las funciones del administrativo y la gestión de turnos en el mostrador.

[Gonzalo Ferraro] Modificar historia 18: Anotar en el documento la solicitud de modificar la historia de usuario 18 para el próximo sprint.

[Agustín Echavarria] Revisar documentación: Examinar los cambios realizados en el archivo de referencia. Validar que la edición sea correcta.

[Agustín Echavarria] Eliminar ticket 32: Eliminar el elemento numero 32 del sistema. Confirmar que la tarea ya no aparezca en las pantallas.

Detalles

Ajustes en el plan de la demo y las diapositivas: Agustín Echavarria indicó que se realizaron modificaciones junto con Diego en el plan de la demo y en las diapositivas, ajustando el

proyecto para que coincida con las fechas de entrega (00:00:00) (00:03:07). Asimismo, Agustín Echavarria mencionó que las diapositivas y el plan de demo se mantuvieron similares a los de la ocasión anterior, reutilizando la estructura previa con la aprobación del equipo (00:14:49).

Modificaciones en el acceso y edición de fichas médicas: Agustín Echavarria explicó que se eliminaron la historia de usuario 49 y 50 y se ajustaron los permisos de los profesionales médicos sobre las fichas clínicas. Se estableció que cualquier médico puede ver la ficha de un paciente, pero se especifica claramente qué profesional elaboró el registro, y las fichas solo se pueden editar el mismo día de la consulta, requiriendo una nueva consulta médica para realizar modificaciones posteriores, conforme a lo solicitado por Diego (00:07:16).

Definición de precios de consulta y descuentos por obra social: Luca Fueyo, Agustín Echavarria y Gonzalo Ferraro debatieron sobre cómo se estructuran los costos y descuentos de las obras sociales (00:08:36). Se acordó simplificar el modelo para que cada médico pueda fijar un precio específico para cada obra social, o bien que el administrador establezca un descuento global predeterminado aplicable sobre el precio base de la consulta (00:09:52) (00:34:03). Adicionalmente, Maximo Fernandez y Simon Marconi señalaron la necesidad de contar con una pantalla específica para cargar el precio base de la consulta aplicable a todos los profesionales (00:39:58).

Evaluación del camino crítico del proyecto: Agustín Echavarria comentó que al revisar el proyecto, el camino crítico aparecía completamente en color azul con un error de visualización. Ante esto, Gonzalo Ferraro aclaró que no existe un camino crítico activo debido a que el proyecto cuenta con holgura temporal en los sprints (como el sprint 3), permitiendo retrasos de varios días sin afectar la fecha final de entrega del proyecto (00:13:11).

Gestión de turnos de vacunación y roles administrativos: Luca Fueyo, Agustín Echavarria y Gonzalo Ferraro revisaron las interfaces de los wireframes para la gestión de turnos de vacunación y la atención en el mostrador. Se discutió que tanto el personal de enfermería como el administrativo pueden otorgar turnos, buscar personas por documento o correo electrónico, y reservar turnos a nombre de terceros, vinculando esto con la historia de usuario 28 y 29 sobre dosis aplicadas (00:16:28) (00:22:59).

Revisión de la gestión y modificación de coberturas médicas de pacientes: Durante la revisión de los wireframes de la historia de usuario 32, Maximo Fernandez, Agustín Echavarria y Gonzalo Ferraro cuestionaron la funcionalidad que permitía al personal administrativo modificar la obra social o prepaga de cualquier paciente (00:27:09). Se concluyó que las personas pacientes deben gestionar la propia cobertura desde la cuenta personal, por lo que se decidió eliminar dicha opción de la interfaz administrativa, manteniendo únicamente la gestión general de obras sociales (00:29:01).

Registro de pagos por efectivo o transferencia y emisión de comprobantes: Luca Fueyo, Maximo Fernandez y Gonzalo Ferraro analizaron la historia de usuario 35 referente al registro de pagos. Se determinó que al seleccionar un turno y registrar el pago en efectivo o transferencia, el sistema genera automáticamente un comprobante de pago (00:42:50). El acceso a esta pantalla se realizará desde el listado de turnos del día tras verificar la asistencia de la persona paciente (00:44:42).

Alineación del flujo de atención, asistencia y cobro entre médicos y personal administrativo: Luca Fueyo, Gonzalo Ferraro, Franco Lazzarin y Simon Marconi debatieron sobre las incongruencias en el flujo de pantallas donde el profesional médico marca la asistencia de la persona paciente frente al rol del personal administrativo encargado de cobrar (00:46:03). Aunque en la realidad operativa el personal administrativo cobra antes de la consulta, el equipo decidió mantener la lógica actual para evitar cambios estructurales masivos en el proyecto, estableciendo que el médico marcará un estado de consulta cumplida que habilitará al personal administrativo para proceder al cobro y emitir el comprobante, dejando documentado este aspecto para optimizarlo en el siguiente sprint (00:51:44) (00:53:51).

Asignación de roles en el marcado de asistencia y estado de consultas: Agustín Echavarria cuestiona por qué el personal administrativo marca ausentes y si este debería habilitar automáticamente al médico para cargar la ficha médica. Gonzalo Ferraro explica la diferencia entre la presencia en sala y la finalización de la atención, comparándolo con los estados de un taller entre trabajando y terminado o cumplido. Tras un debate entre Agustín Echavarria, Franco Lazzarin, Luca Fueyo y Gonzalo Ferraro sobre médicos freelancer sin secretaria, se discute la gestión de comprobantes de pago en efectivo y la validación con Diego (00:58:15).

Consulta, visualización y estructura de las fichas médicas: Luca Fueyo y Gonzalo Ferraro examinan la consulta del historial clínico y fichas de pacientes como María García, mientras

Sebastián Sandoval consulta sobre los estados para el ministerio y el médico (01:00:40). Agustín Echavarria propone que, al habilitar la secretaría, la ficha aparezca directamente para completar dado que no se puede tener más de un turno simultáneo (01:02:47). Franco Lazzarin y Gonzalo Ferraro detallan que las fichas de otros médicos son de lectura y funcionan como documentos acumulativos por cada consulta según las guías de Gemini, en lugar de modificar una ficha única por paciente (01:03:39).

Redirección en fichas médicas y control de descargas y auditorías: Gonzalo Ferraro propone agregar un botón que redireccione a la ficha médica al cargar un nuevo diagnóstico (01:06:43). Agustín Echavarria indica que los diagramas de wireframes se encuentran reubicados en la carpeta WF. Luca Fueyo repasa la historia de usuario 41 sobre la descarga en archivo PDF y la historia de usuario 44 relacionada con registros de auditoría por accesos indebidos al historial clínico (01:08:50).

Gestión de archivos adjuntos, bloqueos de agenda y notificaciones a pacientes: Franco Lazzarin propone adjuntar estudios como radiografías y archivos PDF directamente dentro de la ficha del paciente. Luca Fueyo y Maximo Fernandez analizan la historia de usuario 22 sobre el aviso a pacientes ante el bloqueo de agenda por parte de un profesional, evaluando si conviene integrarla como un correo automático dentro de la historia de usuario 30 (01:11:32). Finalmente, Franco Lazzarin y Luca Fueyo acuerdan dejar la historia planteada de manera simple, advirtiendo a la otra comisión sobre su posible estado incompleto (01:15:45).

Gestión de turnos desde el mostrador y diferenciación de pantallas por roles: Luca Fueyo revisa junto a Gonzalo Ferraro los filtros y la interfaz de usuario para la selección de turnos de otras personas, aclarando que la pantalla es compartida pero muestra botones específicos según el rol del usuario frente al administrador (01:47:29). Asimismo, Luca menciona la pantalla de cobertura para la historia de usuario 33 (01:50:24). Por último, Luca Fueyo sugiere fusionar la historia de usuario 28 con la 17 de turnos de mostrador, mientras Gonzalo Ferraro acota que la funcionalidad también debe aplicar para el rol de enfermería, acordando que la pantalla sirva tanto para usuarios como para enfermeras (01:53:57).

Configuración de pantallas para enfermería y personal administrativo: Gonzalo Ferraro señaló que el personal de enfermería no cuenta con una pantalla equivalente a la del personal administrativo para emitir turnos libremente. Luca Fueyo y Gonzalo Ferraro discutieron mantener la configuración actual de la pantalla 28 sin realizar modificaciones para enfermería y administración. Asimismo, Luca Fueyo y Agustín Echavarria revisaron las

pantallas 34 y 35, identificando las funciones correspondientes al registro de pagos en efectivo o transferencia, y el cálculo del importe social. Se acordó dejar dichas configuraciones sin cambios (01:56:29).

Revisión de documentación y edición de wireframes: Agustín Echavarria y Luca Fueyo revisaron el estado de la documentación editada, comentando sobre la eliminación del wireframe de la pantalla 32, la cual continúa cargada en su propia pantalla. Francisco Nuñez confirmó que los cambios realizados consistieron en retirar dicho wireframe de la pantalla 32 y aplicar una edición de texto, quedando igual que el prototipo (01:58:08).

Planificación de la próxima reunión y demostración: Francisco Nuñez consultó al equipo sobre la fecha para el siguiente encuentro, sugiriendo el miércoles o el jueves. Franco Lazzarin, Luca Fueyo y el resto de los participantes confirmaron que la próxima reunión corresponderá a la demostración del sistema (01:58:08).

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean precisas. Obtén sugerencias y descubre cómo Gemini toma notas

*Cómo es la calidad de **estas notas específicas?** Responde una breve encuesta para darnos tu opinión; por ejemplo, cuán útiles te resultaron las notas.*